

Gastroenteritis aguda y deshidratación

1. Introducción y relevancia clínica

La **gastroenteritis aguda (GEA)** es un **cuadro diarreico de inicio súbito** (<14 días), caracterizado por aumento en la frecuencia, volumen o fluidez de las deposiciones, habitualmente acompañado de **vómitos y fiebre**.

Es **una de las principales causas de morbilidad infantil en Chile y el mundo**, responsable de un número importante de hospitalizaciones y, en países en desarrollo, de mortalidad por **deshidratación aguda**.

En Chile, la mayoría de los casos son leves y **de manejo ambulatorio**, gracias al acceso a agua potable, lactancia materna y al uso generalizado de **sales de rehidratación oral (SRO)** según los protocolos del **Programa IRA-EDA del MINSAL**.

En el **EUNACOM**, este tema se evalúa casi todos los años, especialmente en preguntas sobre:

- Clasificación de la deshidratación.
 - Manejo según plan de rehidratación (A, B o C).
 - Uso de zinc y mantenimiento nutricional.
 - Criterios de hospitalización.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Mecanismos fisiopatológicos

1. Diarrea osmótica:

- Aumento del contenido osmótico intestinal → retención de agua (ej. intolerancia a lactosa).

2. Diarrea secretora:

- Toxinas bacterianas (como *Vibrio cholerae* o *E. coli* enterotoxigénica) → secreción activa de agua y electrolitos.

3. Diarrea inflamatoria:

- Invasión de la mucosa intestinal (ej. *Shigella*, *Salmonella*, *Campylobacter*) → fiebre alta, sangre y moco en deposiciones.

4. Diarrea motora:

- Aceleración del tránsito intestinal (menos frecuente).

b. Agentes etiológicos frecuentes

Grupo etario	Agentes más comunes
<2 años	Rotavirus (más frecuente), Norovirus, Adenovirus entérico
>2 años	<i>E. coli</i> enterotoxigénica, <i>Salmonella</i> , <i>Shigella</i> , <i>Campylobacter jejuni</i>
Inmunocomprometidos	<i>Giardia lamblia</i> , <i>Cryptosporidium</i> , <i>Cytomegalovirus</i>

Desde la introducción de la **vacuna anti-rotavirus en Chile (2010)**, este agente ha disminuido significativamente, aunque sigue siendo el más relevante en lactantes no vacunados.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Cuadro clínico típico

- Diarrea aguda (≥3 deposiciones blandas o líquidas en 24 h).
- Vómitos (habitualmente al inicio).
- Fiebre leve o moderada.
- Dolor abdominal y distensión.
- Signos de **deshidratación** progresiva (ver más abajo).

b. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Características distintivas
Diarrea persistente (>14 días)	Sospechar intolerancia secundaria o parasitosis.
Diarrea con sangre	Disentería bacteriana (Shigella, Campylobacter).
Vómitos sin diarrea	Gastroenteritis inicial o cuadro obstructivo.
Apendicitis / invaginación	Dolor abdominal localizado, compromiso general.

c. Evaluación del estado de hidratación (según OMS / MINSAL)

Signos clínicos	Sin deshidratación	Deshidratación leve/moderada	Deshidratación grave
Estado general	Activo, alerta	Irritable, inquieto	Letárgico o inconsciente
Ojos	Normales	Hundidos	Muy hundidos
Lagrimo / saliva	Presentes	Escasos	Ausentes
Sed	Normal	Aumentada, bebe ávidamente	Incapaz de beber o bebe muy poco
Pliegue cutáneo	Normal	Se retrae lentamente	Muy lentamente (>2 seg)

Pulso / llenado capilar	Normal	Débil o prolongado	Filiforme, pulso ausente
Pérdida estimada de peso corporal	<3 %	3–9 %	≥10 %

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Diagnóstico

El diagnóstico es clínico.

En casos leves o moderados, **no se requieren exámenes**.

b. Indicaciones de exámenes

Solicitar laboratorio solo si:

- Diarrea con sangre o moco.
- Fiebre alta persistente.
- Deshidratación grave.
- Sospecha de sepsis o enfermedad sistémica.
- Lactantes menores de 3 meses.
- Inmunodeprimidos.

Exámenes útiles:

- **Hemograma y electrolitos plasmáticos** (en deshidratación grave).
- **Coprocultivo** (si diarrea con sangre o persistente).
- **Test rápido de rotavirus** (en hospitales).
- **BUN y creatinina:** control de función renal en deshidratación prolongada.

5. Tratamiento (según Guía MINSAL / OMS 2024)

a. Principios generales

1. **Rehidratación adecuada** (pilar del tratamiento).
2. **Mantener alimentación** (no suspender leche materna).
3. **Uso de zinc** en menores de 5 años.
4. **Evitar medicamentos innecesarios** (antibióticos, antidiarreicos).

b. Planes de rehidratación (MINSAL 2024)

Plan	Grado de deshidratación	Tipo de rehidratación	Objetivo
Plan A	Sin deshidratación	Oral en domicilio	Prevenir deshidratación
Plan B	Leve/moderada	Oral supervisada en sala	Corregir déficit leve/moderado
Plan C	Grave o shock	Endovenosa / sonda nasogástrica	Corregir déficit grave y shock



Plan A: prevención en domicilio

- Ofrecer **SRO** después de cada deposición:
 - <2 años: 50–100 mL.

- 2–10 años: 100–200 mL.
 - 10 años: según sed.
 - Mantener alimentación habitual y lactancia.
 - Educar signos de alarma (sed intensa, vómitos persistentes, sangre en heces, letargia).
-



Plan B: rehidratación oral supervisada

- **SRO 75 mL/kg en 4 horas.**
 - Reevaluar signos clínicos y repetir si es necesario.
 - Si no tolera vía oral → sonda nasogástrica o EV.
 - En vómitos: administrar pequeñas cucharadas frecuentes.
-



Plan C: rehidratación endovenosa

En deshidratación grave o shock.

- **Solución recomendada:** Ringer Lactato (o SF 0,9 % si no disponible).
 - **Esquema OMS / MINSAL:**
 - <12 meses: 30 mL/kg en 1 hora + 70 mL/kg en 5 horas.
 - 12 meses: 30 mL/kg en 30 min + 70 mL/kg en 2,5 horas.
 - Reevaluar constantemente (pulso, diuresis, conciencia).
 - Si no se puede canalizar vía EV → por sonda nasogástrica (rehidratación oral alternativa).
-

c. Alimentación y zinc

- **Lactancia materna:** continuar siempre.
 - **Realimentación temprana:** introducir alimentos blandos tras la rehidratación.
 - **Suplementación con zinc (OMS/MINSAL):**
 - <6 meses: 10 mg/día por 10–14 días.
 - ≥6 meses: 20 mg/día por 10–14 días.
 - Favorece la recuperación intestinal y reduce recurrencias.
-

d. Antibióticos: solo en casos seleccionados

Indicación	Fármaco sugerido
Shigelosis	Azitromicina 10 mg/kg/día por 5 días
Cólera	Azitromicina o ciprofloxacino según sensibilidad
Giardiasis / amebiasis	Metronidazol 15 mg/kg/día por 5–7 días
Diarrea del viajero (E. coli enterotoxigénica)	Azitromicina (1 dosis diaria 3 días)

6. Complicaciones y pronóstico

a. Complicaciones

- **Deshidratación grave / shock hipovolémico.**

- **Hiponatremia o hipernatremia.**
- **Insuficiencia renal aguda prerrenal.**
- **Intolerancia secundaria a lactosa.**
- **Desnutrición aguda.**

b. Pronóstico

Excelente si se aplica rehidratación temprana y adecuada.

La mortalidad en Chile es prácticamente nula gracias al acceso a SRO y atención primaria eficiente.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. La **rehidratación oral (SRO)** es el pilar fundamental del tratamiento.
2. **Diagnóstico clínico:** la mayoría de los casos no requiere laboratorio.
3. **No suspender alimentación ni lactancia.**
4. **Zinc por 10–14 días** reduce duración y recurrencia.
5. **Plan B:** 75 mL/kg en 4 h; **Plan C:** 100 mL/kg total en 6 h.
6. **Antibióticos solo en disentería o casos específicos.**
7. El **signo más sensible de deshidratación: sed aumentada.**

☐ **Errores frecuentes:**

- Usar suero fisiológico o jugos caseros como reemplazo del SRO.
- Indicar antibióticos empíricos sin indicación.
- No reevaluar al niño tras la rehidratación oral.
- Suspender leche materna innecesariamente.
- No entregar educación de signos de alarma a los padres.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **gastroenteritis aguda** es causa frecuente de diarrea y deshidratación en lactantes.
2. El **diagnóstico es clínico**, basado en signos de deshidratación.
3. **Rehidratación oral con SRO** es el tratamiento de elección (Plan A, B o C).
4. **Zinc 10–20 mg/día** por 10–14 días favorece la recuperación.
5. **No suspender lactancia ni alimentación.**
6. **Antibióticos** solo en casos seleccionados (Shigella, cólera, Giardia).
7. El pronóstico es **excelente** con manejo oportuno y educación familiar.